EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	73994
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-11-13 09:30:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE HERNAN MALDONADO QUI◆ONES			RUN	: 4.681.150-K
F.Nac	: 11-01-1941	Edad	: 82 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: TRES ESQUINAS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 91748377		
Fecha Ingreso	: 11-11-2023	Fecha Egreso	: 2023-11-13 09:30:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonia basal izquierda en tratamiento
SDRA 2ª Resuelto
EPOC
HTA
DM2 IR
ERC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Masculino De 82 Años Con Antecedentes Mórbidos Cistostomia, Hta, Dmir, Ca Pancreatico, Erc Cin Hd, Epoc. Sin Alergias Conocidas
Hgt: 487mg/Dl Sat: 94% Con 10lto X Maf
Acude Por Compromiso De Estado General Desde Esta Mañana, Asociado A Desaturacion Hasta 70 En Domicilio.
Ingresa Desorientado, Apoyado Con Maf 10 Litros Saturando 92%, Coopera Con Ex Fisico .
Usuario Persiste Con Insuficiencia Respiratoria, Aumento De Parámetros Inflamatorios Y Marcada Leucocitosis.
En Imágenes De Tc De Tórax Se Evidencia Atelectasia Con Signos De Sobreinfección.
Última Evolución De Cx En Cae Indica Lesión Pancreática No Cancerosa.
Hace 1 Mes En Tto Con Azitromicina Por Obs Neumonía
Se Decide Hospitalizar E Inicio De Atb

Paciente Con Buena Evolución Clinica Estable, Afebril, Sin Dolor, , Con Destete Progresivo De O2 Suplementario, Actualmente Sin Requerimiento De Oxígeno . Con Buena Tolerancia A Alimentacion Vo Diuresis Por Cistotomia, Deposiciones (+)
Ex Fisico -> Vigil, Clote; Mucosas Rosadas, Hidratadas, Llene Capilar < 2 Segs
Cardiaco Rr2t Nas Pulmonar Mp (+) Crepitantes En Base Izquierda Extremidades Sin Edema, Sin Signos De Tvp. Neurológico Vigil Orientado Glasgow 15 Ptos .
Exámenes De Laboratorio A La Baja Pcr Control 43,2 .

PLAN DE MANEJO:

Hospitalizar en Hodom
Completar tto atb
kine respiratoria - motora

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia por 11 dias ev
4. Clindamicina 600 mg c/6 hrs por 4 dias vo
5. Salmeterol 2 puff c/12 hrs por AC
6. Bromuro de ipratropio 2 puff c/8hrs por AC
7. Quetiapina 100 mg, medio comp al dia VO
8. Insulina NPH 20 UI AM - 10 UI PM SC
9. HGT c/8 hrs + IC segun esquema
10. KNT resp una vez al dia
11. control sos urgencia

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina : 0,40 clearence Calculado(MDRD) : 205,95 Lactato : 0,8 Nitrógeno Ureico : 10 Uremia : 22 Sodio (Na) : 134,00
Potasio (K) : 3,60 Cloro (Cl) : 99,0
Hemoglobina : 13,1 Hematocrito : 39,6 Recuento de leucocitos : 14,70
Recuento Hematies : 4,60 Plaquetas : 357
Segmentados : 61 Linfocitos : 27 Monocitos : 7

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO